Standard tekst til behandlingsplan skabelon Anoreksi:

Evalueringsdato

Afkryds i "Evalueres løbende".

(Skal ændres ved nye undersøgelsesresultater, ændringer i pts tilstand eller overordnet behandlingsstrategi samt ændringer i pts diagnose og afsluttet udredning)

Behandlingsansvarlig læge (BAL)

Noter den behandlingsansvarlige overlæge (Kirsten Kjer Keller)

Primær behandler

Noter primær læge/psykolog

Følgende planer foreligger:

Her nævnes: Handlingsplan, mestringsplan, kriseplan, kostplan m fl.

Psykiatriske og somatiske diagnoser

Psykiatriske diagnoser skrives med diagnosekode + diagnose.

Eks. F50.0; F50.1

Diagnoser på kormorbiditet

Somatiske diagnoser skrives blot diagnose + kode

Aktuelle problemstillinger/symptomer, der underbygger diagnoserne

Kort beskrivelse af problemstillinger og forløb (inkl. varighed) før aktuelle indlæggelse. F.eks

Pt. indlægges grundet utilstrækkelig effekt af ambulant behandling med stagnering i vægt/ drastisk vægttab på xx kg. Spiseforstyrrelsen er ved indlæggelse karakteriseret ved vægt på xx kg, højde på xx cm svt. BMI xx. Restriktivt spisemønster og kompenserende adfærd i form af tvangspræget motion/opkastninger/laksantia. Psykologiske symptomer i form af vægtangst, fedmefølelse og forvrænget kropsbillede. Menstraution er fraværende.

Indlæggelsen er forudgået af en forventningsafstemmende forsamtale.

Relevante symptomer på komorbiditet beskrives kort.

Plan for undersøgelser

Psykiatrisk/psykologisk undersøgelse:
Ingen planlagt under indlæggelse

Somatisk undersøgelse:

Løbende kontrol med blodprøver, EKG, måling af blodtryk og puls ødem-måling samt vejning.

Foreliggende undersøgelsessvar og observationsfund:
Lettere syg:
Underernæring med tab af underhudsfedt. Målte værdier og blodprøver er stabile.

Svært syg: (eksempler, de relevante skrives)
Fysiske symptomer i form af træthed, svimmelhed(besvimelser) og nedsat kraft. Kognitivt påvirket med nedsat koncentrationsevne og hukommelse samt latenstid. Forstoppelse af og til mavesmerter. Hyppige vandladninger/besvær med at holde på vandet. Mfl.
Objektivt ses svær underernæring med væsentligt tab af underhudsfedt og tab af muskelmasse. Perifer afkøling, cyanose og forsinket kapillær respons. Tegn på atrofi med tør, skællende hud, og hårtab. Der ses lanugobehåring.
(Ødemer periorbitalt/ bilat i underekstremiteter/ flanken.)
Blodprøver med påvirkning af flere organsystemer. Ustabilt og lavt blodsukker.
EKG med langsom hjerterytme.
Menstruation er fraværende.

Eller helt kort:
Svært underernæret med væsentligt tab af underhudsfedt. Somatisk påvirket svarende til graden af undervægt. Blodprøver med påvirkning af flere organsystemer.
Der vil i opstartsfasen være behov for tæt somatisk monitorering herunder med blodprøver, måling af værdier og somatisk undersøgelse.

Mål - aktuelle og langsigtede

Aktuelle:

Stabilisering af somatisk tilstand og vægtindhentning med minimum 1 kg pr uge under indlæggelse. Dette ved igangsættelse af sufficient og regelmæssig spisning. Arbejde med at nedbringe/ophøre med kompenserende og vægtreducerende adfærd. Undersøge udløsende og vedligeholdende faktorer for spiseforstyrrelsen, samt arbejde med mestring.

Mål med behandling på sigt:

Fastholdelse af vægtindhentning gennem regelmæssig og tilstrækkelig spisning efter udskrivelse, indtil den anbefalede stabiliseringsvægt er nået.

På sigt fravær af psykologiske spiseforstyrrelsessymptomer.

(Disse varer ofte ved i en længere periode efter målvægt er nået.)

Arbejde med bagvedliggende problematikker mhp. at undgå tilbagefald.

Observationsplan

Personale kigger til dig flere gange i vagten

Plan for behandling

Medicinsk.

Tilskud af vitaminer og mineraler.

Psykoterapeutisk

Samtaler med behandler og kontaktpersoner. Deltagelse i terapigruppe.

Miljøterapeutisk

Støtte til spisning i spisegruppe og efterfølgende samvær. Deltagelse i fysioterapigruppe. Deltagelse i afsnittets øvrige aktiviteter.

Socialt

Inddragelse af socialt netværk

Forventet varighed af behandlingen

Vurderes løbende

Alternativt

Antal uger, hvis dette allerede fastlagt

Samarbejde med pårørende, herunder børn

Du opfordres til at invitere pårørende til samtaler, samt at pårørende i øvrigt inddrages efter behov

Patientens holdning til behandlingsplanen

Der er givet fyldestgørende information om den aktuelle behandling. Du samtykker til behandlingen

Alternativt

Du er blevet indlagt imod din vilje og samtykker ikke til behandlingen. Du er orienteret omkring din behandling. Vi vil løbende under indlæggelsen ved samtale med dig revurdere om du fortsat

skal forblive indlagt imod din vilje. Vi vil fortsat inddrage dig, og afsøge om der er områder af behandlingen vi kan nå til enighed omkring. //

Samarbejde med andre, herunder eventuelle planer for rehabilitering og/eller forebyggelse og sundhedsfremme

Eksempler:

"Inddragelse af Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, som har kendskab til pt fra ambulant forløb"

"Inddragelse af dit bosted/kommune/bostøtte i form af netværksmøde"

“Inden der kan planlægges udskrivelse skal der være kontakt med støttetilbud, og der skal planlægges overgang”